



WEEKLY REPORT

友善、公平、藝術、洞察



讓我們創造明天，而不是去想昨天發生了什麼事
-蘋果創辦人 賈伯斯

做夢的勇氣與創造360度醫學人生的能力

2025年的最後，我們問自己：在快速變動的醫療世界裡，我們想成為什麼樣的團隊？走過一整年的探索，我們嘗試著在科技與人性之間找平衡，在效率與溫度之間做出選擇。如今站在2026年的起點，這個問題有了新的延伸——我們想培養出什麼樣的醫療工作者？

醫學教育，不只是知識的傳遞，也是價值觀的傳承，是臨床思維的養成，更是將「以人為本」這個理念，深植在每一位學習者心中的過程。當我們談論AI工具、談論效率優化、談論創新思維時，會回到一個問題：我們希望下一代醫療工作者，在面對病人時，看見什麼？在做出判斷時，依循什麼？

2026年的第一季，我們將把目光聚焦在臨床教育。不只是「教什麼」和「怎麼教」，更要深入探討「為什麼教」——在這個知識唾手可得的時代，教育者的角色是什麼？當學習者可以向AI提問任何問題，我們如何引導他們學會提出「對的問題」？當標準作業流程越來越完善，我們如何培養他們在不確定中做出明智判斷的能力？

教育，是一場漫長的對話。它需要時間、需要耐心、需要在每一個教學現場中不斷調整與反思。未來這一季，讓我們一起走進臨床教育的各個角落，在教與學的互動中，找到讓醫療持續進步、又不失溫度的可能。

教學部
週戰報

是什麼讓我不再懷疑自己！

在無數個值班的深夜裡，身為醫療人員的我們，是否都曾閃過這樣的自我懷疑：

「我到底在做什麼？」在日復一日、高壓且僵化的排程中，我們很容易感覺自己像是生產線上的作業員。病人彷彿成了一個個待修復的代號——這個是肩膀問題、那個是膝蓋受傷。而原本投入這個行業的熱情，在繁瑣的行政流程與各種難以理解的投訴中，逐漸被磨損得只剩下疲憊。

芷嫣治療師在演講中真誠地剖開了自己的脆弱，她坦言，這份對病人的敏銳觀察並非與生俱來的天賦，而是生命用痛楚換來的禮物。



曾經的她，會盡責地叫醒在病床旁熟睡的家屬起來協助復健；直到父親罹患癌症，當她自己成為那個聽到醫院廣播「999」緊急代碼就驚恐顫抖的家屬時，她才終於真正「懂」了那份深不見底的無助感。現在的她，會選擇讓疲憊的家屬多睡一會兒，因為她深知，此刻的休息比標準化的復健流程更貼近人性的真實需求。



在裂痕中，讓光透進來

這正是從看見「疾病」到看見「全人」的關鍵轉變。就像那位堅持不拔除鼻胃管的病人，表面上看似抗拒醫療建議，但當治療師願意停下腳步傾聽時，才發現那條管子的背後，是為了讓太太能夠一日三餐回來幫他灌食牛奶——那不只是一條醫療管路，而是這對夫妻在病痛中僅存的依賴與愛的連結。

「敏銳不是天生的，而是在看似枯燥的日常裡，被時間一點一滴打磨出來的理解。」真正的醫病連結，往往不需要華麗的言語技巧，而只是一句真誠的：「我懂你在痛，而我會陪你一起面對。」

請別忘了，我們以為微不足道的舉手之勞，往往正是他人正在努力跨越的巨大門檻。在醫療現場這些看似不完美的裂痕中，我們若願意多給予一點點溫柔，光就會從那裡透進來，照亮彼此前行的路。

從資料到行動：打造臺灣傳染病監測的智慧防線

臺灣傳染病監測體系的建立，核心驅動力源於2003年SARS疫情的慘痛教訓。當時因對國內外疫情偵測與準備不足，在莊人祥次長等專家的推動下，政府建構了一套強調速度（Speed）、規模（Scale）與系統整合（System Integration）的自動化架構。這套體系目前以「4E」成就作為核心指標：

電子病歷通報（Electronic EMR Reporting）

透過與醫院資訊系統整合，系統能自動擷取病人基本資料，將法定傳染病通報時間從9分鐘大幅縮短至4分鐘。目前全國已有92家醫院參與，涵蓋超過50%的通報案量。



實驗室自動通報

（Electronic Laboratory Reporting, LARS）

採用HL7 FHIR與國際標準碼LOINC，自動化傳輸21項病原體（如流感、新冠、腸病毒等）的檢驗結果。系統每日自動傳輸約2,500筆陽性個案資料，不僅加快通報速度，更提升了資料品質與完整性。

症候群監測

（Early Warning - Syndromic Surveillance）

體系包含RODS（即時疫情監測系統）與健保資料庫，涵蓋全國99%的人口。該系統能透過ICD編碼在1小時內即時偵測異常趨勢。例如2007年爆發的紅眼症疫情，傳統定點醫師系統無法偵測，但RODS能精準捕捉訊號。



事件監測

（Event-based Surveillance, EBS）

利用AI與大型語言模型（LLM）主動搜集全球新聞、社交媒體與官方訊息，並自動進行翻譯與摘要。2013年中國H7N9疫情，便是透過Google News關鍵字搜尋，在新聞發布不到20分鐘內即掌握資訊並啟動應變機制。

此外，政府透過「疾管家」LINE機器人與大眾溝通，目前擁有超過千萬訂閱者，提供疫苗接種提醒與AI自動問答服務。奇美醫院作為長期合作夥伴，在EMR通報與LARS資料品質上表現優異，並成功建置HL7-FHIR傳輸機制，榮獲多項特優獎勵。

臺灣透過整合電子通報、實驗室自動化、症候群預警與AI事件偵測，成功將零散的醫療資訊轉化為主動且具預測性的公共衛生生態系統。這種「4E」架構不僅優化了現有的防疫效率，更確保臺灣能在面對未來新興傳染病威脅時，展現出強大的防疫韌性與數位治理能量。這套監測體系就像是為國家裝上了多頻譜雷達，它不只能精準追蹤已知的疾病分布，還能透過AI捕捉地平線外微弱的事件信號，實現真正的超前部署。

在例行之中，重新對齊我們的初衷

教學部 淑雅

在例行的會議與流程之中，每一項安排，都是為了維持醫院穩定而有品質的運作。近期，我重新檢視這些工作，嘗試回到更核心的思考：我們所做的每一個行動，是否真正支持了教學、臨床與整體醫療品質？

當出發點被重新對齊，行政流程不再只是把事情完成，而成為確保制度能被落實、專業得以持續發展的基礎。每一項任務，都是讓團隊能專注於本業、讓醫療體系穩定前行的重要一環。這樣的視角轉換，也帶來了實際而深刻的差異。



住院醫師座談會



在近期的住院醫師座談會中，過往常被視為例行性意見蒐集的場合，這一次選擇用「理解痛點、尋找改善可能」的心態來傾聽。當我們把每一個反映視為制度可以優化的依據，原本看似零散的抱怨，逐漸拼湊出同仁對工作環境與訓練品質的期待。那不只是問題的累積，而是一種願意說出真實感受的信任。

在住院醫師醫學會論文評選的規劃上，我們也重新檢視活動的初衷——不是完成一次評選，而是真正鼓勵住院醫師投入研究、參與學術討論。過去仰賴系統自動擷取摘要，雖然論文篇數多，卻容易讓參與流於被動。自明年度起，將改採主動報名的方式，希望讓願意親自執行研究、站上發表舞台的醫師被看見。這不只是制度的調整，而是讓鼓勵回到實質意義的嘗試，也讓人開始期待更多出於熱忱的參與。

這段過程中，最深的體會是：當我們換一個角度重新看待活動，整體的意義也隨之改變。當「為何而辦」變得清楚——為了讓醫院更好、讓醫療體系更卓越——每一項安排，便成為推動醫學教育向前的一小步。

或許，真正重要的不是活動本身，而是在開始之前，多問自己三個問題：這件事的核心價值是什麼？我們希望傳遞的是什麼？又該如何讓它不只是「做完」，而是「做到產生影響」？

願我們都能在日復一日的忙碌中，持續保有這樣的提醒，讓看似例行的工作，一點一滴累積成更有意義的改變。